

HSC | GLOBAL

AVALIAÇÃO CLÍNICA ISO 14155 • ANVISA, FDA E CE

APOSTILA DO ALUNO • MÓDULO 5

ISO 14155: boas práticas em investigação clínica

Texto de estudo para acompanhar e revisar o Módulo 5

MÓDULO	5 de 5, ao vivo
DOCUMENTO BASE	ISO 14155:2026; Regulamento (UE) 2017/745, Anexo XV; 21 CFR 812; RDC 837/2023
INSTRUTOR(A)	Equipe HSC Global

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar esta apostila

Esta apostila segue a sequência das aulas do Módulo 5, bloco a bloco, sem repetir os slides. Explica o mesmo conteúdo com outras palavras e outros exemplos, do ponto de vista de quem avalia uma investigação clínica.

No início de cada capítulo, a faixa **Na aula** indica o bloco e os slides correspondentes, a pergunta de revisão ligada ao capítulo e o que observar enquanto assiste. Depois de cada capítulo há uma página de anotações com campos editáveis: digite direto no PDF (Adobe Acrobat Reader ou navegador) e salve, ou imprima e escreva à mão.

> **REGRA DE OURO DO CURSO**
>
> O que vale numa auditoria é o texto oficial vigente, não o resumo. Sempre que esta apostila citar um documento, abra o original pelo link e confira a revisão antes de usar.

•	Mapa do módulo: aula, apostila e caderno	3
1	De 2011 a 2026: como a norma evoluiu	4
2	O plano de investigação clínica pelo Anexo A	7
3	Integridade de dados: ALCOA+	10
4	Brasil, União Europeia e Estados Unidos	13
5	Papéis e responsabilidades	16
6	Encerramento, PMCF e síntese do curso	19
7	Glossário	22
8	Para revisar	23

MAPA DO MÓDULO

Aula, apostila e caderno

O Módulo 5 é ao vivo e tem três blocos: evolução normativa e contexto regulatório, papéis e encerramento, e a síntese do curso. Os blocos foram divididos em seis capítulos por assunto.

BLOCO	TEMA	NA AULA	NESTA APOSTILA	PARA REVISAR
1	Evolução da norma, de 2011 a 2026	Slides 3 a 4	Capítulo 1	Perguntas 1 e 2
1	Plano de investigação clínica	Slides 5 a 6	Capítulo 2	Pergunta 3
1	Integridade de dados	Slide 7	Capítulo 3	Pergunta 4
1	Brasil, UE e EUA	Slides 8 a 9	Capítulo 4	Perguntas 5 e 6
2	Papéis e responsabilidades	Slides 10 a 11	Capítulo 5	Pergunta 7
2 e 3	Encerramento, PMCF e síntese	Slides 13 a 17	Capítulo 6	Pergunta 8

Sua rotina em cada bloco

1 • PREPARE

Antes do encontro

Leia o capítulo com a ISO 14155:2026 aberta e anote o que não ficou claro.

2 • PARTICIPE

Durante a aula

Acompanhe os slides indicados na faixa Na aula e registre exemplos e dúvidas na página de anotações.

3 • PRATIQUE

Depois da aula

Responda às perguntas do capítulo Para revisar sem consultar o texto e confira depois.

DEPOIS DO CURSO

Mantenha a ISO 14155:2026 e a legislação de cada jurisdição à mão e confira sempre a revisão vigente antes de citar um requisito ou prazo.

CAPÍTULO 1

De 2011 a 2026: como a norma evoluiu

NA AULA **Bloco 1 • slides 3 a 4** **Para revisar • Perguntas 1 e 2**

Repare em quais mudanças alteram o que o avaliador pede para ver durante o estudo, e não só no final.

A edição vigente da norma é a ISO 14155:2026, quarta edição, que substituiu a de 2020. Entender o caminho de 2011 até hoje ajuda você a ver por que certas evidências passaram a ser esperadas.

O salto de 2011 para 2020

A aula mostra o que mudou da edição de 2011 para a ISO 14155:2020. Os princípios de boas práticas clínicas passaram para o corpo da norma e a qualidade passou a ser planejada desde o início. Para o avaliador, o foco mudou: não basta um estudo que terminou bem, é preciso mostrar como ele foi controlado enquanto acontecia.

- **Gestão da qualidade do estudo** aplicada pelo patrocinador.
- **Monitoria baseada em risco**, desde que justificada no plano de monitoria.
- **Registro público** da investigação.
- **Estatística mais exigente** no plano de investigação clínica.
- **Gestão de risco** ligada à ISO 14971:2019 ao longo do estudo e requisitos ajustados ao estágio de desenvolvimento clínico.

A edição de 2026

- **Riscos em três categorias:** do dispositivo e do comparador, avaliados pela ISO 14971:2019; dos procedimentos exigidos pelo CIP; e da condução do estudo, que serve de base para a monitoria baseada em risco.
- **Avaliação de benefício-risco** passa a ser o termo usado.
- **Comitês:** a norma trata do comitê de eventos clínicos (CEC). Quando não houver comitê de monitoramento de dados (DMC), o CIP precisa justificar. As condições de suspensão do estudo ficam no regimento do DMC.
- **Anexo K**, informativo, sobre desenho do estudo e estimandos.
- **Consentimento** que cobre amostras biológicas e dados de saúde, e novo consentimento quando um estudo suspenso é retomado.
- **Exceção a critério de elegibilidade** só por emenda ao CIP.
- **Anexo ZA**, que relaciona a norma ao Anexo XV do MDR.

CAPÍTULO 1 (CONTINUAÇÃO)

De 2011 a 2026: como a norma evoluiu

ERRO COMUM

Citar a ISO 14155:2020 como se fosse a edição vigente. Antes de usar um requisito, confira se ele vem da edição de 2026.

IDEIA-CHAVE

De edição em edição, a norma desloca a atenção do resultado final para o controle do estudo e dos seus riscos enquanto ele acontece.

Fonte: ISO 14155:2026; ISO 14155:2020 (histórico).

CAPÍTULO 1 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

De 2011 a 2026: como a norma evoluiu

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 2

O plano de investigação clínica pelo Anexo A

NA AULA **Bloco 1 • slides 5 a 6** Para revisar • Pergunta 3

Observe como cada grupo de conteúdo do plano corresponde a uma pergunta que o avaliador faz sobre o estudo.

O plano de investigação clínica, conhecido pela sigla CIP, é o documento que diz o que o estudo pretende responder e como. A ISO 14155:2026 descreve no Anexo A o conteúdo que ele precisa ter.

Para quem avalia, o CIP é a régua. Tudo o que acontece no estudo é comparado com o que o plano previa: a população incluída, os desfechos medidos, a análise feita. Se o plano é vago, a comparação fica impossível e a confiança nos resultados cai.

Três grupos de conteúdo

GRUPO	O QUE PRECISA EXISTIR	PERGUNTA DO AVALIADOR
Contexto	Identificação do estudo e das partes, justificativa, revisão da literatura, descrição do dispositivo e do comparador	Por que este estudo é necessário?
Desenho	Objetivos, hipóteses, população e critérios de elegibilidade, desfechos definidos de forma operacional, tamanho da amostra e plano estatístico	O desenho responde à pergunta?
Condução	Gestão de dados, monitoria, definição e notificação de eventos adversos, ética, consentimento, seguro, cronograma	O estudo é controlável e seguro?

Um desfecho definido de forma operacional é aquele que qualquer pessoa da equipe mede do mesmo jeito. Dizer "melhora clínica" não basta. O plano precisa dizer o que será medido, quando e com qual critério.

O tamanho da amostra também precisa de justificativa. O avaliador procura as premissas usadas no cálculo: a hipótese, o erro aceito, o poder pretendido e a variabilidade esperada do desfecho. Uma amostra sem premissas declaradas não permite saber se o estudo tinha chance real de responder à pergunta.

O plano também precisa dizer como os eventos adversos serão definidos, registrados e notificados, e como o consentimento será obtido. Esses itens ligam o desenho científico à proteção do participante: um estudo bem desenhado, mas sem regra clara para eventos adversos, não está pronto para começar.

CAPÍTULO 2 (CONTINUAÇÃO)

O plano de investigação clínica pelo Anexo A

ATENÇÃO

Mudanças no CIP depois da aprovação precisam ser formalizadas e, quando exigido, aprovadas antes de valerem. Na edição de 2026, incluir um participante fora de um critério de elegibilidade só é possível por emenda ao CIP. Uma análise diferente da prevista, feita sem emenda, enfraquece a conclusão do estudo.

O QUE O AVALIADOR CONFERE

Coerência interna

Objetivo, hipótese, desfecho e análise apontam para a mesma pergunta.

O QUE O AVALIADOR CONFERE

Rastreabilidade

Cada versão do plano está identificada e as alterações estão justificadas.

IDEIA-CHAVE

O CIP é a régua do estudo: o que não está previsto nele dificilmente sustenta uma conclusão.

Fonte: ISO 14155:2026, Anexo A.

CAPÍTULO 2 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

O plano de investigação clínica pelo Anexo A

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 3

Integridade de dados: ALCOA+

NA AULA **Bloco 1 • slide 7** **Para revisar • Pergunta 4**

Pense em um registro real de estudo e verifique, letra por letra, se ele passaria em cada critério.

Um resultado só vale tanto quanto os dados que o sustentam. O conjunto de critérios conhecido como ALCOA+ resume o que torna um dado confiável e verificável.

A ISO 14155:2026 exige que os dados do estudo sejam rastreáveis, com alterações registradas e justificadas. Na prática, quem avalia escolhe registros e refaz o caminho: do relatório para o banco de dados, do banco para o formulário de relato de caso e do formulário para o documento fonte, como o prontuário.

O que cada letra cobra

CRITÉRIO	O QUE SIGNIFICA
Atribuível	Dá para saber quem registrou e quando
Legível	Qualquer revisor consegue ler e entender
Contemporâneo	Registrado no momento em que o fato ocorreu
Original	É o primeiro registro, ou uma cópia certificada dele
Exato	Corresponde ao que aconteceu e confere com a fonte

O sinal de mais acrescenta quatro qualidades: completo, consistente, duradouro e disponível. Um dado completo não tem campos esquecidos. Um dado consistente não contradiz outro registro do mesmo participante. Um dado duradouro sobrevive ao tempo de guarda exigido. Um dado disponível pode ser consultado quando o avaliador pedir.

Esses critérios valem tanto para papel quanto para sistemas eletrônicos. No caso eletrônico, o avaliador também quer saber se o sistema foi validado, quem tem acesso e como as alterações ficam registradas. Um sistema que permite apagar valores sem deixar rastro compromete todos os dados que passaram por ele, mesmo que nenhum erro tenha sido encontrado.

A integridade também depende das pessoas. Equipe treinada, registros feitos na hora e conferência periódica pela monitoria reduzem o risco de erro antes que ele chegue ao banco de dados.

CAPÍTULO 3 (CONTINUAÇÃO)

Integridade de dados: ALCOA+

Sinais que chamam a atenção

- Registros feitos em lote, dias depois das visitas
- Correções sem identificação de quem corrigiu e por quê
- Sistema eletrônico sem trilha de auditoria
- Dados do formulário que não aparecem no prontuário

DICA

Uma correção não é problema. O problema é a correção que apaga o valor anterior ou não deixa rastro. O avaliador espera ver o valor original, o novo valor, quem alterou, quando e o motivo.

IDEIA-CHAVE

Dado bom é o que outra pessoa consegue reconstruir até a origem, sem depender da memória de quem registrou.

Fonte: ISO 14155:2026.

CAPÍTULO 3 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Integridade de dados: ALCOA+

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 4

Brasil, União Europeia e Estados Unidos

NA AULA **Bloco 1 • slides 8 a 9** **Para revisar • Perguntas 5 e 6**

Note o que é comum às três jurisdições e o que muda em cada uma.

A ISO 14155:2026 é uma base comum, mas não substitui a legislação de cada país. Um estudo conduzido em várias jurisdições precisa cumprir a norma e, ao mesmo tempo, as regras locais de ética, autorização e notificação.

Para quem avalia, a pergunta é dupla. O estudo seguiu as boas práticas da norma? E atendeu às exigências da jurisdição onde foi conduzido? A segunda resposta depende sempre do texto legal vigente, que você deve conferir antes de citar qualquer prazo.

ASPECTO	BRASIL	UNIÃO EUROPEIA	ESTADOS UNIDOS
Base legal	Lei 14.874/2024, RDC 837/2023, Resolução CNS 466/2012	MDR, Art. 62 a 82 e Anexo XV	21 CFR 812, além das regras de consentimento e de IRB
Ética	Sistema CEP e CONEP	Comitê de ética do Estado-Membro	IRB da instituição
Autoridade	Anvisa, quando aplicável	Autoridade competente do Estado-Membro	FDA, para estudos de risco significativo
Transparência	Registro público do estudo	EUDAMED	ClinicalTrials.gov

Notificação de eventos graves

Na União Europeia, o MDR trata da notificação no Art. 80 e o guia MDCG 2020-10/1 detalha os prazos: imediatamente, e no máximo em 2 dias corridos, quando há risco iminente de morte ou dano grave; no máximo em 7 dias corridos nos demais casos notificáveis. Nos Estados Unidos, o 21 CFR 812.150 pede que o investigador comunique um efeito adverso não antecipado ao patrocinador e ao IRB em até 10 dias úteis. No Brasil, os prazos seguem a RDC 837/2023, que você deve consultar no texto oficial.

Outro ponto comum às três jurisdições é a transparência. A ISO 14155:2026 espera que a investigação seja registrada em uma base de acesso público, e cada região tem a sua. Para o avaliador, o registro público permite comparar o que foi planejado com o que foi relatado, o que ajuda a identificar desfechos trocados ou resultados omitidos.

Em estudos multicêntricos internacionais, o mesmo protocolo passa por comitês de ética diferentes. Cada aprovação precisa estar arquivada, com a versão do documento aprovado e a data.

CAPÍTULO 4 (CONTINUAÇÃO)

Brasil, União Europeia e Estados Unidos

ATENÇÃO

Prazos citados de memória ou copiados de apresentações costumam estar desatualizados. Para o avaliador, só vale o prazo do texto oficial vigente, com a referência exata do artigo.

IDEIA-CHAVE

A norma dá a base comum; cada jurisdição acrescenta seus prazos, sistemas e formatos.

Fonte: Lei 14.874/2024; RDC 837/2023; MDR, Art. 62 a 82 e 80; MDCG 2020-10/1; 21 CFR 812.150.

CAPÍTULO 4 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Brasil, União Europeia e Estados Unidos

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 5

Papéis e responsabilidades

NA AULA **Bloco 2 • slides 10 a 11** **Para revisar • Pergunta 7**

Acompanhe quem decide, quem executa e quem verifica em cada atividade da matriz.

Uma investigação clínica envolve várias partes, e cada uma responde por coisas diferentes. Quando os papéis se confundem, as falhas aparecem justamente nas fronteiras entre elas.

A ISO 14155:2026 distribui as responsabilidades principalmente entre o patrocinador, que responde pelo estudo como um todo, e o investigador principal, que responde pela condução no centro. O comitê de ética protege os participantes e o monitor verifica, em nome do patrocinador, se o estudo segue o plano.

ATIVIDADE	PATROCINADOR	INVESTIGADOR	COMITÊ DE ÉTICA	MONITOR
Recrutamento	Acompanha	Executa	Aprova o material	Verifica
Consentimento	Fornece o modelo	Conduz	Aprova o termo	Verifica
Eventos graves	Avalia e notifica	Identifica, trata, comunica	Avalia	Verifica
Fechamento do banco	Decide	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

A matriz mostra um padrão: quem executa raramente é quem verifica. O investigador conduz o consentimento, o comitê aprova o termo e o monitor confere se o processo seguiu a versão aprovada. Essa separação existe para que um erro de uma parte seja percebido por outra. Algumas decisões, como o fechamento do banco de dados antes da análise final, cabem só ao patrocinador.

O comitê de ética tem papel próprio, que não depende do patrocinador. Ele avalia o estudo antes do início, acompanha emendas e eventos relevantes e pode suspender a aprovação se a proteção dos participantes estiver em risco. A norma descreve o que se espera dessa atuação.

CAPÍTULO 5 (CONTINUAÇÃO)

Papéis e responsabilidades

Delegar não é transferir responsabilidade

O patrocinador pode contratar terceiros para tarefas como monitoria ou gestão de dados. Mesmo assim, continua responsável pelo resultado. O mesmo vale para o investigador que delega tarefas à equipe do centro: a delegação precisa estar registrada e as pessoas precisam estar qualificadas para o que fazem.

O QUE O AVALIADOR PROCURA

Registro de delegação

Quem pode fazer cada tarefa no centro, desde quando e com qual treinamento.

O QUE O AVALIADOR PROCURA

Contratos e acordos

Responsabilidades transferidas a terceiros descritas por escrito.

ERRO COMUM

Uma pessoa que não consta no registro de delegação assina um termo de consentimento ou preenche um formulário de relato de caso. Isso gera dúvida sobre a validade do registro.

IDEIA-CHAVE

Cada atividade do estudo tem um responsável claro, e a delegação nunca apaga a responsabilidade de quem delegou.

Fonte: ISO 14155:2026.

CAPÍTULO 5 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Papéis e responsabilidades

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 6

Encerramento, PMCF e síntese do curso

NA AULA **Bloco 2 e Bloco 3 • slides 13 a 17** Para revisar • Pergunta 8

Veja como o fim do estudo se conecta ao acompanhamento pós-mercado e à avaliação clínica.

O estudo não termina na última visita. Ele termina quando os dados estão completos, os centros foram encerrados, o relatório final foi escrito e as autoridades foram informadas.

Como o estudo termina

- **Término**. Acontece no ponto definido no CIP, em geral a última visita do último participante.
- **Encerramento dos centros**. A monitoria final confirma dados completos, dispositivos contabilizados e arquivo organizado.
- **Relatório final**. O relatório da investigação clínica, previsto na norma, é escrito mesmo quando o resultado é desfavorável.
- **Comunicação**. Na União Europeia, o MDR, Art. 77, pede o relatório em até 1 ano do fim do estudo. Nos Estados Unidos, o 21 CFR 812.150 pede o relatório final do patrocinador em até 6 meses.

> ATENÇÃO
>
> Resultado negativo também é resultado. Omitir ou atrasar dados desfavoráveis compromete a avaliação clínica e a ética do estudo, porque esconde informação que protege futuros pacientes.

No encerramento, o avaliador também olha para os participantes. Quem ainda precisa de acompanhamento depois do fim do estudo deve ter esse cuidado garantido, e os dispositivos que sobraram precisam ser devolvidos ou descartados com registro.

Pré-mercado e acompanhamento pós-mercado

ANTES DO MERCADO

Investigação pré-mercado

Demonstra segurança e desempenho iniciais, muitas vezes com desenho controlado.

DEPOIS DO MERCADO

PMCF

Confirma segurança e desempenho no uso real, muitas vezes com estudo observacional.

Nos dois momentos, quando há investigação clínica, a condução segue a ISO 14155:2026. O que muda é a pergunta: antes do mercado, você quer saber se o dispositivo funciona e é seguro; depois, quer confirmar isso ao longo do tempo e em uma população maior.

CAPÍTULO 6 (CONTINUAÇÃO)

Encerramento, PMCF e síntese do curso

O que o curso deixa

Ao longo dos cinco módulos, você viu que a avaliação clínica depende de ética, de dados confiáveis e de método. A norma organiza esses três pilares e facilita a aceitação dos dados em várias jurisdições. A responsabilidade continua depois da aprovação: vigilância e acompanhamento clínico pós-mercado acompanham o dispositivo enquanto ele estiver em uso.

IDEIA-CHAVE

Fazer ciência que protege as pessoas: dado bom nasce de ética e continua sendo observado depois que o produto chega ao mercado.

Fonte: ISO 14155:2026; MDR, Art. 77; 21 CFR 812.150.

CAPÍTULO 6 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Encerramento, PMCF e síntese do curso

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 7

Glossário do módulo

CIP

Plano de investigação clínica: documento que define objetivos, desenho, população, desfechos e análise do estudo.

Patrocinador

Pessoa ou organização responsável pelo início, gestão e financiamento da investigação clínica.

Monitoria baseada em risco

Abordagem que concentra a verificação nos dados e processos críticos, com justificativa documentada.

Documento fonte

Primeiro registro de uma informação do participante, como o prontuário.

Trilha de auditoria

Registro automático de quem alterou um dado, quando, o valor anterior e o motivo.

ALCOA+

Critérios de integridade de dados: atribuível, legível, contemporâneo, original e exato, mais completo, consistente, duradouro e disponível.

Comitê de ética

Colegiado independente que avalia e acompanha o estudo para proteger os participantes.

Efeito adverso não antecipado

Efeito grave relacionado ao dispositivo que não estava previsto na análise de risco ou no plano.

Relatório da investigação clínica

Documento final com os resultados e conclusões do estudo, previsto na norma.

CEC

Comitê de eventos clínicos: grupo que avalia e classifica eventos clínicos do estudo de forma independente.

Estimando

Descrição precisa do efeito que o estudo pretende estimar, tratada no Anexo K da ISO 14155:2026.

PMCF

Acompanhamento clínico pós-mercado: coleta proativa de dados clínicos depois que o dispositivo chega ao mercado.

CAPÍTULO 8

Para revisar

Responda com as suas palavras, sem consultar o texto. Depois, confira no capítulo indicado.

1. Por que a ISO 14155:2026 separa os riscos em três categorias, e o que isso muda na monitoria do estudo? *(Cap. 1)*

2. Em que situação a monitoria baseada em risco deixa de ser aceitável para o avaliador? *(Cap. 1)*

3. Por que um desfecho mal definido no CIP enfraquece a conclusão, mesmo com bons resultados? *(Cap. 2)*

4. Como você refaria o caminho de um dado, do relatório até a origem, para testar a integridade? *(Cap. 3)*

5. O que permanece igual e o que muda quando o mesmo estudo é conduzido no Brasil, na Alemanha e nos Estados Unidos? *(Cap. 4)*

6. Por que citar um prazo de notificação sem conferir o texto oficial é um risco para a avaliação? *(Cap. 4)*

CAPÍTULO 8 (CONTINUAÇÃO)

Para revisar

7. O que acontece com a responsabilidade do patrocinador quando ele contrata uma empresa para fazer a monitoria? *(Cap. 5)*

8. Por que um resultado primário negativo ainda precisa de relatório final e de comunicação às autoridades? *(Cap. 6)*

HSC | GLOBAL

HSC Academy • Avaliação Clínica de Dispositivos Médicos ISO 14155

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

www.hscglobalgroup.com